

消化器症状:薬剤師の実践ポイント

服薬指導・相互作用・病院との連携のポイント

1 消化器症状の薬薬連携 — 持ち帰りの制吐薬と止瀉薬

病院薬剤師	病院と共有する情報	保険薬局薬剤師
① 催吐性リスクに応じた制吐薬の設定・レジメン監査	催吐性リスク (レジメン)	① 持ち帰りの制吐薬(デキサメタゾン等)の服用日を具体的に説明
② 投与日の制吐薬と、持ち帰りの制吐薬の処方設計	持ち帰りの制吐薬 (日数・服用日)	② 止瀉薬・含嗽薬・下剤の使い方と受診の目安を伝える
③ イリノテカンのUGT1A1確認、早発性下痢への備え	悪心・下痢の程度 (一番つらかった日)	③ 遅発性悪心・下痢・口内炎を投与後数日で電話確認
④ 外来化学療法室での制吐薬・止瀉薬の使い方の説明	食事量・体重 (脱水の目安)	④ 前回の悪心の程度を聞き、次コースの制吐薬強化を提案
⑤ 前回の症状を評価し、次コースで制吐薬を強化		⑤ 市販の下痢止め・胃腸薬の自己判断での使用を確認

2 重症度(CTCAE Grade)と保険薬局での対応の目安

軽い — 重症度 — 重い

Grade1	Grade2	Grade3	Grade4
下痢(ふだんとの比較) 排便回数が1日4回未満の増加	下痢(ふだんとの比較) 1日4～6回の増加	下痢(ふだんとの比較) 1日7回以上、失禁、入院が必要	下痢(ふだんとの比較) 生命を脅かす
口内炎 症状がない、または軽度	口内炎 中等度の痛み。食事の工夫が必要	口内炎 高度の痛み。経口摂取が困難	口内炎 生命を脅かす
保険薬局での対応の目安 セルフケアを支援(止瀉薬・含嗽・保湿の使い方)	保険薬局での対応の目安 処方医・病院へ連絡し、休薬・減量の判断につなげる	保険薬局での対応の目安 至急の受診を勧める(夜間・休日の連絡先を案内)	保険薬局での対応の目安 救急受診

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌 添付文書 併用禁忌	オランザピン 血糖上昇作用	既往・疾患 糖尿病(他院で治療中の場合も)	高血糖・糖尿病性ケトアシドーシス	お薬手帳で糖尿病治療薬の有無を確認
注意 添付文書 併用注意	アプレピタント CYP3A4阻害	処方薬 デキサメタゾン	デキサメタゾン濃度↑	デキサメタゾンは減量して使用(用量を確認)
注意 添付文書 併用注意	アプレピタント CYP2C9・3A4誘導	処方薬 ワルファリン・経口避妊薬	INR↓・避妊効果↓	INRを確認、他の避妊法の併用を説明
注意 添付文書 併用注意	オランザピン 中枢抑制の重複	処方薬 生活習慣 睡眠薬・抗不安薬・飲酒	眠気・ふらつき→転倒	他院の睡眠薬と飲酒を確認、就寝前の服用を説明
確認 服薬指導上の注意	止瀉薬(ロペラミド) 症状を隠す	市販薬 市販の下痢止め(ICI大腸炎・感染性腸炎が疑われる時)	診断・治療の遅れ	自己判断で使わず、まず連絡するよう指導
確認 服薬指導上の注意	5-HT3受容体拮抗薬・オピオイド 便秘作用の重複	市販薬 市販の刺激性下剤	便秘の遅延・下剤の過量	下剤の処方と市販薬の使用状況を確認

4 服薬指導タイムライン(声かけ例)

① 治療開始前	② 投与当日～5日	③ 投与後1～2週	④ 次回来局時
“吐き気止めは、吐き気がなくても決められた時間に飲みます。いつ何を飲むか、紙に書いてお渡ししますね	“2～5日目の吐き気にも備えましょう。水分は少しずつ、下痢が続く時は下痢止めを指示どおりに	“やわらかい歯ブラシで口の中を清潔に。うがいは食後と寝る前に、こまめにしましょう	“前回の吐き気や下痢はどうでしたか。一番つらかった日と、何回くらいだったか教えてください
✓薬局で確認 お薬手帳でレジメンの催吐性リスク、他院での糖尿病治療(オランザピン)	✓薬局で確認 電話フォローで遅発性の悪心・水分量・下痢の回数を確認	✓薬局で確認 口内炎の痛みと食事への影響、含嗽薬・保湿剤の使い方	✓薬局で確認 悪心・下痢・口内炎をGradeで記録、体重・便秘の有無
△ここに注意 前回つらかった方は予期性悪心の対策を相談	△ここに注意 水分がとれない・1日7回以上の下痢は至急連絡	△ここに注意 痛みで食事や水分がとれない時は連絡	△ここに注意 Grade2以上はトレーニングレポートで制吐薬等の強化を提案